内科学含诊断学 循环系统疾病

考频（9-12 题，★★★）：A_1 3-5 A_2 3-6 B 0-2 X 1

①心肌疾病：肥厚型心肌病、扩张型心肌病、限制型心肌病、病毒性心肌炎
②心包疾病：心包积液、急性非特异性心包炎、缩窄性心包炎
③感染性心内膜炎
④高血压
⑤心瓣膜病：二狭、二闭、主狭、主闭
⑥冠心病：稳定型心绞痛、不稳定型心绞痛、急性心肌梗死
⑦心力衰竭：慢性心衰、急性心衰
循环系统疾病损害了心肌的自律细胞
⑧心律失常：房颤、室上速、室速、房室阻滞等
⑨心脏骤停

可以想成循环系统的三个并发症

注意：先复习《病理学》循环系统疾病相关章节，再复习内科学，并回顾式串联《生理学》

肥心病：肥厚的心肌细胞叫“胖胖不灵活”，主要影响舒张速度→回心血↓↓→没血可射
扩心病：由于遗传或免疫原因导致心肌细胞“挂掉了”→心肌收缩能力↓↓→有血射不出

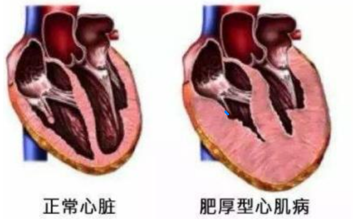
核心精讲 • 心肌疾病

（性感认识：肥心病没血可射 VS 扩心病有血射不出）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

左室流出道梗阻

一、肥厚型梗阻性心肌病



1.病因：常染色体显性遗传（常显肥）——肌球蛋白等编码基因突变：

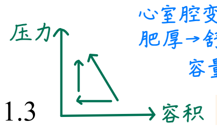
①扰乱肌纤维排列（心肌细胞排列紊乱呈漩涡状）肥厚型心肌病是青年人、运动员猝死最常见的原因

钙超载会损害心肌
②心肌对 Ca^{2+} 敏感性增强→增加心律失常、猝死风险

③横桥释放所需能量增加→心脏舒张功能↓

二人亲三人分：与ADP结合时亲和力高，与ATP结合时亲和力低所以横桥释放需要ATP

肌动蛋白 亲和力异常增高
横桥
肌球蛋白
①



心室腔变小→前负荷↓
肥厚→舒张速度↓→回心血量↓
容量↓ 压力↑
心肌肥厚时该曲线左上移

2.心脏特点

②

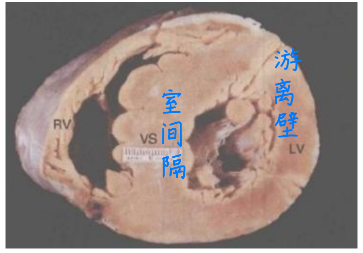
①心室明显**不对称肥厚**：尤其**室间隔肥厚**（15mm）、厚度室间隔/左室游离壁＞1.3

②**左室流出道梗阻**、心室腔变小（左室显著）、左室舒张末压力↑（胖胖不灵活）通过舒张产生负压，由于“胖胖不灵活”导致顺应性下降→舒张速度↓→左室舒张末压力↑

③**SAM** 征：收缩期**二尖瓣**前叶向前移动与室间隔左侧心内膜接触（主动脉瓣下心内膜增厚）

④主要导致**舒张性心衰**（超声心动图 E/e’≥15、E/A＜1.2 姨姨叫我幺儿）
大 小
肌球蛋白突变→横桥释放所需能量增加→舒张性心衰，后期都会变成收缩性心衰
舒张障碍→负压抽吸回血↓→e↓→左心房代偿收缩(增强的第四心音)a↑

e：正常人在舒张早期、二尖瓣开放会产生较大的左心室血液流入速率（左心室的抽吸）
a：舒张晚期（左心房收缩）只会产生较小的左心室血液流入速率，因此正常情况e/a>1



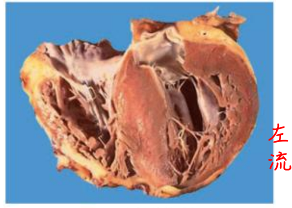
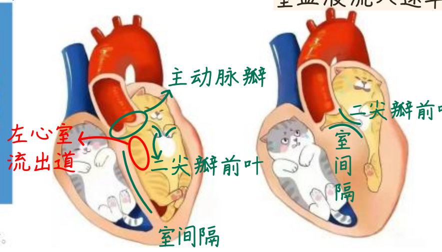
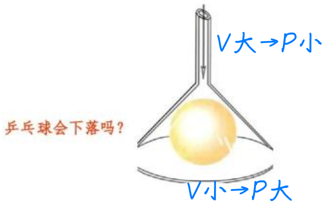


图 9-28 肥厚型心肌病
室间隔非对称性肥厚，心室腔及左心室流出道狭窄。


主动脉瓣
左心室流出道
二尖瓣前叶
室间隔
二尖瓣前叶
室间隔



3.临床特点 左室舒张末期压力↑→心房压力↑→肺静脉回流障碍 交感兴奋→心率加快→舒张期↓↓→充盈量↓↓→搏出量↓↓

③

①劳力性呼吸困难（最常见）、**胸痛**，运动**低**血压、**晕厥**

②可有**心尖收缩期杂音** 左心室流出道梗阻→射到主动脉根部血液↓→冠脉流量↓→胸痛

③**胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音，常喷射样**：收缩期射血时血液流经狭窄的流出道
左心室流出道梗阻会出现杂音，在室间隔的位置听诊

SAM现象→二尖瓣前移→二尖瓣关闭不全

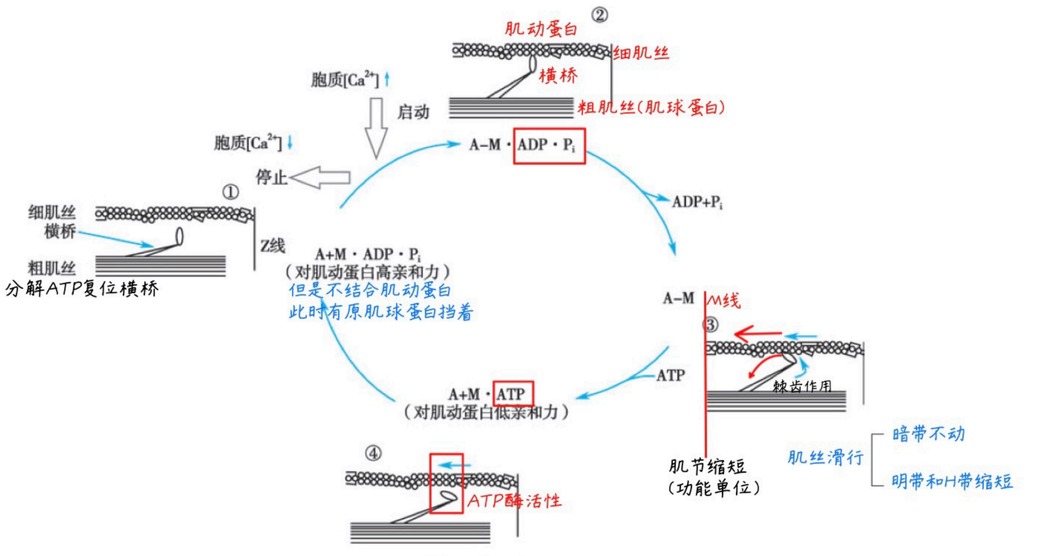


图 2-29 横桥周期示意图

① 串联生理学：

通过横桥周期完成肌丝滑行而实现肌肉的收缩，实质上是将分解ATP获得的化学能转变为机械能的过程。若肌肉在保持长度不变的条件下进行收缩，由于横桥头部和杆部之间的桥臂具有弹性，横桥的扭动可使桥臂被拉长，借其弹性回缩而产生张力（此时肌丝不发生滑行！）。若产生的张力能克服阻力而发生肌丝滑行，则表现为肌肉缩短（肌丝滑行）。

肌肉收缩所能产生的张力由每一瞬间与肌动蛋白结合的横桥数决定，而肌肉缩短的速度则取决于横桥周期的长短

② 理顺知识点：

肥厚型心肌病HCM呈现心室（多为左心室，但绝不是心房）明显非对称肥厚，尤其是室间隔非对称性肥厚，即厚度室间隔/左室游离壁>1.3，此时心室容积减小，前负荷减小，且由于心室明显非对称肥厚，导致心肌顺应性降低，心肌舒张速度减慢，即心肌舒张产生负压的速度减慢，故舒张末压力增加，即“胖胖不灵活”，回心血量降低，前负荷同样减小。
（VS 肥心病HCM是遗传因素导致的不对称肥厚，区别于后负荷增大导致的心肌代偿性肥厚，此时为对称性肥厚）

由于左室流出道梗阻，左心室代偿收缩，导致流出道处血液流速高，故此时压强较小，导致收缩期时二尖瓣前叶向前移动与室间隔左侧心内膜接触，此时称为SAM现象，可引起二尖瓣增厚、主动脉瓣下心内膜增厚，进一步加重左室流出道梗阻。故肥心病HCM的表现与主动脉瓣狭窄相似，但注意杂音发生的部位不同，注意听诊部位。（杂音是循环系统重要体征，但也常常是陷阱）

肥心病HCM是肥厚的心肌细胞顺应性降低，主要影响舒张功能（舒张速度），故HCM患者是舒张功能障碍，导致“没血可射”，即舒张功能障碍导致负压抽吸回血减少即E波降低，而左心房代偿性收缩回血即A波升高，即E/A<1.2。

③ 理顺知识点：

于舒张功能而言，左心与肺循环密切相关，右心与体循环密切相关，即心肺不分家。肥心病HCM患者因左心室明显不对称肥厚，导致其心肌顺应性降低，舒张速度降低，左心室舒张末压力增加，继发左房内压力升高，肺静脉回流障碍，导致肺循环淤血，出现呼吸困难，劳力性呼吸困难作为最早出现的症状，即劳力时心脏负荷增加更易出现症状。
肥心病HCM患者因心肌明显非对称肥厚，导致肥厚心肌上心肌毛细血管数量未增加，即密度降低，血供减少，且左心室流出道梗阻，导致射到主动脉根部的血流减少，即流向冠脉的血减少，共同导致心肌供血不足，引起心绞痛/胸痛。
正常生理情况下交感神经兴奋导致血压升高（“四正效应”，即心肌收缩性、传导性、自律性、兴奋性均升高），但肥心病HCM患者运动时交感神经兴奋，心率加快，此时舒张期缩短，本身HCM患者舒张速度减慢舒张功能障碍，心率加快舒张期缩短，心室充盈时间减少，回心血量减少，搏出量显著减少，出现运动时低血压、晕厥等反常表现。

增强心肌收缩力→更高速的血液通过狭窄的流出道→局部负压↑→流出道梗阻更严重→杂音↑

④

使杂音↑	**强心苷**、**硝酸酯类**（扩静脉→回心血量↓静止）、**站位**、**Valsalva**（紧闭声门用力呼气→胸腔负压可变为正值→回心血量↓）等
使杂音↓	**β-R 拮抗剂**、**非二氢吡啶 CCB**、**蹲位**、**卧位**（蹲下↓、躺下↓）等

肥心病
- 流出道梗阻,若加重梗阻→杂音↑
- 回心血量减少,若回心血量↓→杂音↑

β-R拮抗剂、非二氢吡啶类CCB减慢心率→舒张期↑→回心血量↑→杂音减弱

可能可能最可能：胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音，可有运动晕厥、家族史

肥心病猝死主要与室性(病变在心肌、心室)快速性心律失常息息相关

4.治疗

β-R拮抗剂
- 负性肌力:减弱心肌收缩力(好事)
- 负性频率:心率↓→舒张期↑→回心血量↑(好事)
- 负性传导:减少了心动过速等心律失常,减少了猝死的风险(好事)

⑤ ①**β-R 拮抗剂（首选）**、非二氢吡啶 CCB（β 的小跟班）、丙吡胺、西苯唑啉（BBBB）VS苯唑西林:耐酶青霉素

适应症和禁忌症类似

②心肌肌球蛋白抑制剂**玛伐凯泰**（肥马）：抑制肌动-肌球蛋白横桥的过量形成→抑制心肌过度收缩。玛伐凯泰不适合 LVEF＜55% 肥心病变成收缩性心衰时不能用玛伐凯泰

CCB
- 二氢吡啶类CCB:主要扩动脉→血压↓↓→窦弓反射→加快心率
- 非二氢吡啶类CCB(如维拉帕米、地尔硫卓)

③**禁用正性肌力药、血管扩张剂、二氢吡啶 CCB、大量利尿剂**（看上述杂音）

如硝酸酯

④室间隔切除术、酒精室间隔消融术

适当使用利尿剂可减轻肺淤血肺水肿
大量使用利尿剂会使回心血量↓↓

5.肥心病是青年运动猝死最常见的原因，猝死高危因素（瘤晕室速家族停、物流延迟散飞）：

①心尖室壁瘤

②晕厥

③室速：持续性室速（SVT）致血流动力学不稳定史、反复非持续性室速（NSVT）

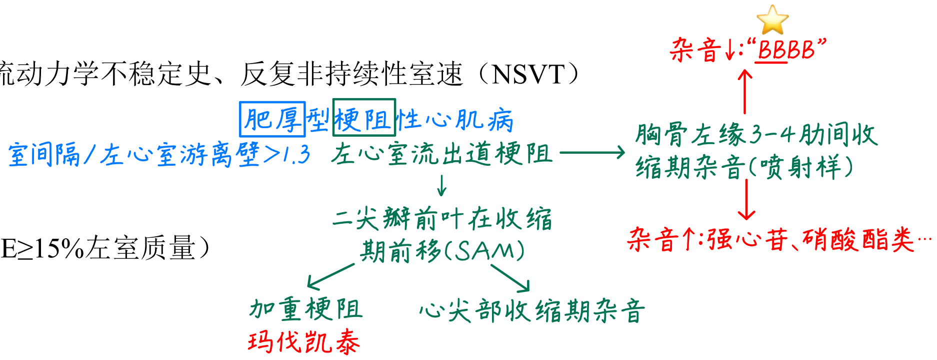
④早发家族史

⑤心脏骤停史

⑥LVEF＜50%

⑦心脏磁共振广泛钆延迟强化（LGE≥15%左室质量）

⑧左室肥厚≥30mm



二、扩张型心肌病

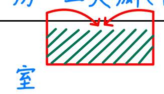
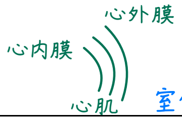
⑥ 1.病因：病毒感染致免疫介导的心肌损害、遗传等

扩张性心肌病可以由病毒性心肌炎演变而来,但二者不能等同

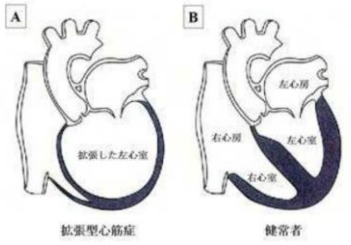
2.心脏特点

左/右心扩大→相对性的门框变大,门没变→相对性关闭不全

⑦

大	各心腔可扩大，**左室扩大最早最显著**，**心界常向两侧扩大**，**房室瓣反流** （心界没有向两侧扩大的扩心病——有辅助检查先看辅助检查）
小	瓣口开放相对减小（总体还是门框大了）　房　二尖瓣(舒张期时)
薄	室壁变**薄** 《内科学》：心室壁变薄，心内膜增厚 《病理学》：心室壁变薄、略厚或正常，心内膜增厚   室壁厚度主要与肌层相关
弱	**心肌收缩能力减弱、室壁运动普遍/弥漫减弱（特征）**

VS 冠心病:室壁运动节段减弱



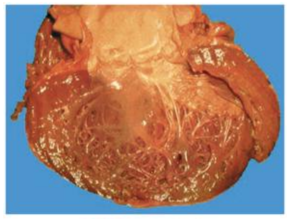
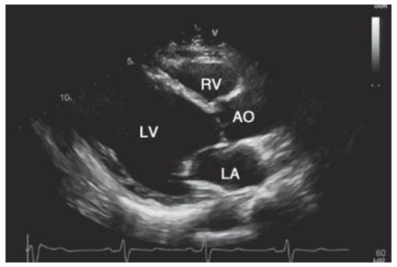


图 9-27　扩张型心肌病

左心室明显扩张，肉柱和乳头肌变扁平。



生理:心腔大→心腔容积↑→心肌收缩力↑→搏出量↑(异长调节)
扩心病:①免疫介导的心肌损害(心肌已经“挂了”);②扩心病的心脏扩张已经超出了异长调节的范围

④ 理顺知识点:

①.强心类药物如强心苷,抑制心肌细胞的钠钾泵,导致胞质内的Na+增加,机体代偿进行Na-Ca反向交换,即此时Na+外流而Ca2+内流,导致心肌收缩能力增强,导致此时更高速的血流通过狭窄的流出道,局部压强进一步降低,导致流出道梗阻更严重,杂音增强。

②.硝酸酯类药物主要扩张静脉,此时血液主要淤滞在静脉中,回心血量减少,肥心病HCM患者本身因心肌肥厚舒张功能障碍,回心血量降低,故不利于HCM患者病情,杂音增强。

③.站立位因重力因素导致其回心血量降低,Valsalva呼吸时紧闭声门用力呼气,可导致胸腔负压变为正值,即此时“不吸血了“,导致回心血量降低,此时HCM患者杂音增大。

④.β-R拮抗剂、非二氢吡啶类CCB可减慢心率,延长舒张期,增加回心血量,利于HCM患者病情,杂音降低,同理,卧位、蹲位同样可增加回心血量,利于HCM患者病情,杂音降低。

⑤ 理顺治疗:

①.β-R拮抗剂:对HCM患者是首选用药,其可负性肌力作用,减轻对狭窄流出道的压迫;可负性频率,延长舒张期,增加回心血量;可负性传导,减少心动过速等心律失常,减少猝死风险。

非二亲吡啶类CCB有负性变频变力作用,可减轻梗阻、改善心室充盈及症状,可作为β-R拮抗剂治疗无效、不耐受或有禁忌症的替代药品,包括维拉帕米、地尔硫草。

②.肌球蛋白抑制剂:玛伐凯泰是目前唯一获批的心肌肌球蛋白抑制剂,其选择性抑制心肌肌球蛋白重链ATP酶的活性,可逆性抑制肌球-肌动蛋白横桥的过量形成,抑制心肌过度收缩,改善心肌顺应性及能量代谢,但值得注意的是不适合左室射血分数LVEF<55%者。

③.禁用正性肌力药(如强心苷增强心肌收缩能力,更高速血流经过狭窄流出道,导致其梗阻更严重)、血管扩张剂(如硝酸酯类药物,主要扩张静脉后导致其血液淤滞在静脉内,回心血量降低)、二氢吡啶类CCB(扩动脉作用强,血压降低后通过窦弓反射可反射性引起心率加快,舒张期缩短,回心血量进一步降低)、大量利尿剂(适当运用利尿剂可减轻肺淤血、肺水肿,改善患者呼吸困难症状,但大量运用利尿剂会使回心血量降低)。

⑥ 理顺扩心病:

扩心病DCM是一类以左心室或双心室扩大伴收缩功能障碍为特征的心肌病,且无法以负荷异常或心肌缺血等来解释。

①.基因突变:DCM患者多为常染色体显性、少数为常染色体隐性或X连锁遗传,相较于HCM,DCM患者的致病基因更多,其中最重要的是心肌骨架蛋白的基因突变尤其是肌联蛋白基因TTN截短突变,尚有肌节、闰盘、桥粒、离子通道等蛋白的基因突变。

②.病毒感染:直接侵袭和由此引发的急慢性炎症和免疫反应是心肌损害并发展为DCM的重要机制。

③.心肌毒物:嗜酒是我国DCM的常见病因,化疗药物和某些心肌毒性药物如蒽环类抗肿瘤药物、锂制剂等也可导致DCM。

⑦ 理顺心脏特点:

①.心腔扩大,且值得注意的是DCM患者各心腔均可扩大(VS HCM患者为心室明显非对称肥厚),且左心室最早最显著,扩心病患者心界常向两侧扩大(重要体征),心界扩大后相对性的“门框”变大而“门”没变,故出现相对性的关闭不全,即房室瓣反流、心尖部收缩期杂音。

②.因DCM患者心腔扩大,心肌收缩能力减弱,导致左心室内有很多血液淤滞,不利于舒张期时二尖瓣开放,即瓣口开放时相对减小(即相对性的关闭不全,出现舒张期杂音),但主要矛盾是心腔扩大而“门”不变,即主要矛盾是相对性的关闭不全,即出现收缩期杂音。

③.DCM患者可为病毒感染由此引发的急慢性炎症和免疫反应引发的心肌损害,故室壁变薄,心内膜可因附壁血栓形成而出现增厚。

④.DCM患者心肌收缩能力减弱,室壁运动出现普遍/弥漫性减弱,而冠心病患者受累冠脉的心肌区域室壁运动节段性减弱。

3.临床特点

杂音
- 部位:二尖瓣的问题(心尖部听)、三尖瓣的问题(胸骨左缘4-5肋间听)、室间隔的问题(胸骨左缘3-4肋间听)
- 时期:如二尖瓣关闭不全(收缩期听)

①起病隐匿 ttsx 左心衰一定要看肺

⑧ ②**左心衰（肺淤血水肿）或全心衰**。左心衰发展到全心衰后呼吸困难等肺淤血症状反而会减轻 右心射血↓

③**心尖或胸骨左缘 4-5 肋间收缩期杂音**
- 左心扩大→相对性二尖瓣关闭不全→心尖部收缩期杂音
- 右心扩大→相对性三尖瓣关闭不全→胸骨左缘4-5肋间收缩期杂音

④导致**收缩性心衰**（超声心动图 **LVEF≤40%**）

可能可能最可能：心界常向两侧扩大、左心衰或全心衰

4.治疗

⑨ ①**同慢性心衰**，首选 **β-R 拮抗剂**（免疫介导患者有抗 β_1-R 抗体→持续激动 β_1-R 致脱敏）

②伴快速房颤可用强心苷（抑制房室结传导），即解决收缩性心衰收缩能力下降的问题又解决房颤可能从房室结传下来引起室颤的问题

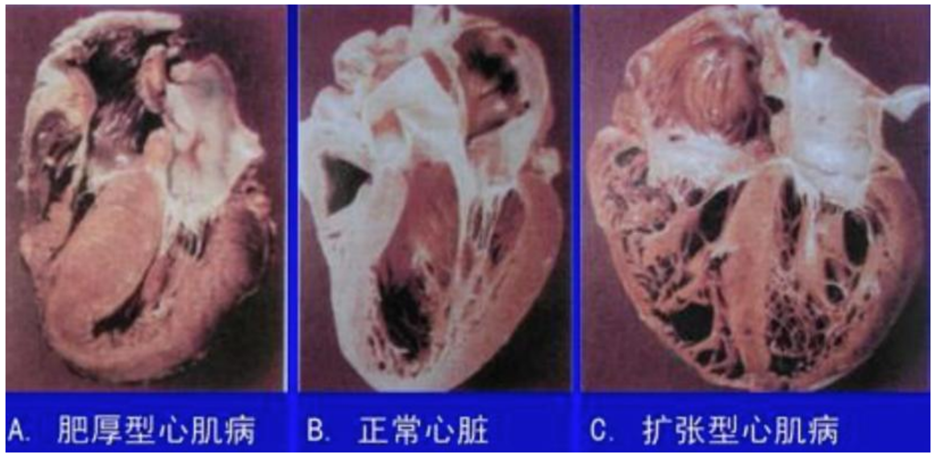
③携带高危致病基因为猝死高危、即使其 LVEF＞35%也应考虑植入型心律转复除颤器 ICD 一级预防 ⑩

注意：肥心病和扩心病均可：

①猝死：**ICD 预防**

②房颤等心律失常、栓塞（附壁血栓脱落），病理 Q 波、ST 段压低、T 波倒置

③**超声心动图**：首选和金标准



三、限制型心肌病 VS 缩窄性心包炎

1.共性 二者理论上来说都会限制左心和右心，但由于肺循环容量较小，体循环容量巨大，所以右心衰表现更突出

①体循环回流障碍（颈静脉怒张等），心界不大或稍大，舒张性心衰

②**超声心动图**：首选和金标准

2.区别 ⑪

	限制型心肌病	缩窄性心包炎
病因	淀粉样变等	结核、急性非特异性心包炎等 渗出纤维素
病理	心内膜及心内膜下心肌纤维化（内衣太紧）	心包粘连增厚、钙化（外套太紧）
体征	**无奇脉** 奇脉:严重的色魔小说包邮	可有奇脉、**心包叩击音**（特点）、心包积液也有 **负性心尖搏动**、室间隔抖动征＝奇脉

严重的右心室增大(顺钟向转位)

缩窄性心包炎:极度吸气→肺血管扩张→回左心血↓
极度吸气→胸腔负压↑(又吸气又吸血↑)→回右心血↑→室间隔向左推
→左室血↓↓→搏出量↓↓→奇脉/吸停脉

限制性心肌病:心内膜纤维化(封住室间隔),无摆动,故无奇脉/吸停脉

⑧ 理顺知识点:

左心功能不全与肺循环淤血密切相关,故DCM患者左心衰后出现肺淤血水肿,当肺循环淤血后导致右心的后负荷增加,右心长期代偿后逐渐失代偿出现右心衰,即由左心衰进展为全心衰。

当右心功能不全时,射向肺动脉的血流量减少,肺循环内的压力降低,肺循环淤血的情况会减轻,此时患者呼吸困难的程度会减轻。但值得注意的是,病例题中出现患者呼吸好转并非是病情好转,此时由左心衰转为全心衰为病情加重。

值得注意的是,DCM患者左心扩大时出现相对性的二尖瓣关闭不全,故出现心尖部收缩期杂音;若DCM患者右心扩大时出现相对性的三尖瓣关闭不全,故出现胸骨左缘4-5肋间收缩期杂音。

瓣膜杂音问题于心瓣膜病专题讲解,注意杂音出现的部位、时期、性质(器质性或功能性)。

⑨ 理顺β-R拮抗剂:

于扩心病DCM的病因中,包括病毒感染导致的免疫损害,患者血清中有抗β1-R的抗体,抗体持续激动β1-R,使受体脱敏,因此使用β-R拮抗剂,可起到增敏受体的作用。

⑩ 理顺ICD:

ICD为心律转复除颤器,于DCM患者的适应证为:
①.心脏骤停史;
②.持续性室速伴或不伴晕厥史;
③.左室射血分数LVEF小于等于35%、NYHA心功能Ⅱ~Ⅲ级,预期生存期大于等于1年。

须指出的是,携带高危致病基因(LMNA、EMD、TMEM43、DSP、RBM20、PLN、FLNC截短变异等)的DCM病人被视为猝死高危者,即使其LVEF>35%,也应考虑ICD一级预防,特别是存在其他危险因素(如室性心动过速、明显LGE)者。

⑪ 理顺限制型心肌病:

限制型心肌病RCM是一组以限制性心室充盈障碍为特征的混合性心肌病,预后较差。
RCM可分为心肌型和心内膜心肌型
心肌型又可分为:①.浸润性/贮积性:细胞内或细胞间异常物质堆积,包括淀粉样变、结节病、糖原贮积症等;②.非浸润性:包括家族性RCM,部分可能与轻型DCM、HCM等有表型重叠。
心内膜心肌型可分为:①.闭塞性,经典的RCM主要累及心内膜,见于心内膜弹力纤维增生症、高嗜酸性粒细胞综合症、放射性损害、蒽环类药物毒性等;②.非闭塞性,多为类瘤样浸润或恶性浸润所致。
心肌淀粉样变性CA是最常见的浸润性RCM。因病因复杂、病理改变各异,经典的RCM的病理改变为心内膜纤维化、钙化及附壁血栓,心内膜下心肌变性坏死及瘢痕形成,此时限制室间隔摆动,故无奇脉。
经胸超声心动图TTE结合多普勒检查是重要的诊断手段,典型表现为心室充盈严重受损,舒张功能明显减低,双心房显著扩大(可见双心房影),若见心肌弥漫性增厚呈毛玻璃样改变提示心肌淀粉样变性CA的可能。

四、病毒性心肌炎

1.临床表现

①**1-3 周感染病史**

必看主诉：1-3 周前驱感染病史（发热、咽痛等上呼吸道感染、消化道症状、皮肤感染等）：病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎、亚甲炎、肾小球肾炎（名字里带“炎”的，考的最多的是急性和急进性）、IgA 肾病（1-3 天）

（心肌炎心包炎亚甲肾炎 3 周现、IgA 肾病 3 天现）

心肌细胞受损

②随后可心悸（与体温不相称一般体温每升高 1 度心率每分钟可增加 12-18 次），心律失常，胸痛

③**左心功能不全为主的表现**：呼吸困难、肺部湿啰音、S_1 低、奔马律、心尖部收缩期杂音 左心扩大→相对性二闭

④严重者可休克、**钟摆律**（**酷似心梗**）第一心音和第二心音都很弱→分不出来,听到单音律

（主要见于非常严重病毒性心肌炎、严重心肌梗死）

⑫ 可能可能最可能：1-3 周感染病史，随后可胸痛、左心功能不全，心悸与体温不相称

必看主诉

病毒性心肌炎和心肌梗死很像
相似点:都有胸痛、左心功能不全表现、休克、钟摆律
鉴别:病毒性心肌炎有1-3周前驱感染病史;心肌梗死没有

2.检查

①金标准：心肌活检（柯萨奇 B 组病毒等）

②病理 Q 波，**心肌坏死标志物如肌钙蛋白 cTn、肌酸激酶同工酶 CK-MB↑**

- 肥心病:q波(室间隔厚了,QRS是心室除极,q波可以看成室间隔除极,深而不宽)
- 心肌梗死:Q波(又宽又深)

注意：病理 Q 波可见于急性 ST 段抬高型心梗、急性心肌炎、肥心病、扩心病等

ST段压低、T波倒置、病理Q波:肥心病、扩心病、限心病、病毒性心肌炎(不要看到病理Q就选心梗)

真题解析 • 心肌疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2016N93-95 A 男性，70 岁，三个月前出现活动后胸闷、头晕，曾晕厥一次，近一周来上一层楼即感心前区疼痛，2 小时前因再次感胸痛伴短暂晕厥来院，既往糖尿病史 12 年，吸烟 35 年。查体：P 82 次/分，BP 100/85mmHg，神志清，颈静脉无怒张，双肺(-)，心尖搏动抬举样，心界向左下扩大，心律整，S_1 低钝，胸骨右缘第二肋间可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，粗糙，喷射状，向颈部放散，$A_2<P_2$，下肢不肿。

主动脉瓣狭窄

血流往主动脉方向　A2↓(看压力)或P2↑

主动脉压力↓=主动脉血液↓

93.该患者最可能的诊断是

A.主动脉瓣狭窄

B.肥厚型梗阻性心肌病 胸骨左缘三四肋间

C.不稳定性心绞痛

D.病态窦房结综合征

有杂音必看杂音,先从杂音入手(一看部位,二看时期,三看器质/功能)

主狭危险因素类似冠心病

94.为明确诊断，以下哪项无创性检查意义最大

A.常规体表心电图

B.24 小时动态心电图

C.冠状动脉 CT

D.超声心动图

95.为缓解胸痛、晕厥，应选用的最佳治疗是

A.静注硝酸酯制剂

B.应用大剂量 β 受体阻滞剂

C.心脏瓣膜置换术

D.介入治疗

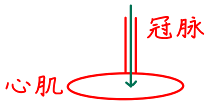
答案:1 ADC

⑫ 理顺知识点:

病毒性心肌炎是嗜心肌病毒感染引起的心肌炎症损伤,主要包括胃肠道病毒如柯萨奇病毒B3、埃可病毒、脊髓灰质炎病毒等;呼吸道病毒如腺病毒、流感病毒等。

病毒性心肌炎多累及左心,注意左心功能不全的症状,患者心率很高,但是体温却不高(正常情况下,体温每升高1度,心率每分钟可增加12-18次)。

诊断病毒性心肌炎一定要看主诉,患者有1~3周的前驱感染史,因病毒性心肌炎表现与心梗类似,即若为中老年、吸烟、高血压、糖尿病病史患者则为心梗。



2.2017N155 X 扩张型心肌病患者辅助检查可出现的异常结果有
A.心电图可见病理 Q 波 q波
B.超声心动图可呈现二尖瓣反流 左心变大→二尖瓣相对性关闭不全→二尖瓣反流
C.核素检查心肌可有灶性（不是弥漫）放射性凋亡 核素用来反映血管、心肌　心肌细胞未摄取核素(心肌细胞/冠脉有问题)
eg.心肌病、心肌炎、心梗
D.心室造影可出现室壁矛盾运动 室壁瘤

3.2021N47 A 一般不会在急性心肌炎病人出现的临床表现是
A.心脏压塞 严重心包积液
B.急性肺水肿 左心功能不全
C.猝死
D.酷似急性心肌梗死

以题带动
知识点复习

4.2022N47 A 以下不符合扩张型心肌病并发心力衰竭的超声心动图表现是
A.LVEF≤40%
B.二尖瓣返流
C.左室壁节段运动减弱 冠心病
D.左心室舒张末内径增大

5.2022N155 X 以下属于肥厚型心肌病猝死风险评估的因素有
A.不明原因的晕厥　瘤晕室速家族停、物流延迟散飞
B.运动时出现高血压
C.反复非持续性室性心动过速
D.左心室壁肥厚≥30mm

6.2023N47 A 可作为鉴别急性心肌炎（看成急性心肌炎的后期）与扩张型心肌病的检查是
A.胸部 X 线片
B.血心肌损伤标志物 扩心病是慢性病程,扩心病部分患者可有轻度升高
C.血 BNP 无特异性,只要心肌细胞受到牵拉,BNP就会增加
D.超声心动图

临床上:1-3周前驱感染
影像:核磁共振检查
金标准:心内膜心肌活检

思维导图 • 心肌疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

		扩心病DCM 收缩功能障碍	肥心病HCM 舒张功能障碍为主	限心病RCM 舒张功能障碍为主
超声	左心室舒张末期内径	↑	↓	↓
	左室壁厚度	薄	明显肥厚,尤其是室间隔	正常或轻度增厚
	左心房	扩大	扩大　左心室压力高,左心房代偿变大	显著扩大
	特征	室壁运动普遍减弱	厚度室间隔/左室游离壁>1.3	双心房显著扩大(毛玻璃样改变)
杂音		心尖部收缩期杂音 胸骨左缘4-5肋间收缩期杂音	心尖部收缩期杂音 胸骨左缘3-4肋间收缩期杂音	一般无
病理		损伤、不均匀肥大	弥漫性肥大	损伤
可能可能最可能		左心衰或全心衰	胸痛、晕厥	右心衰

答案:2-6 ABC A C ACD BD